

病理图文报告

病理号：TCGA-05-4245-01Z-00-DX1

一、患者基本信息

病理号	自动生成（由系统添加，你不要输出）	姓名	留空
性别	留空	年龄	留空
送检科室	病理科	临床诊断	肺部占位性病变，考虑恶性肿瘤可能
标本类型	留空	送检日期	留空
报告日期	留空		

二、镜下所见

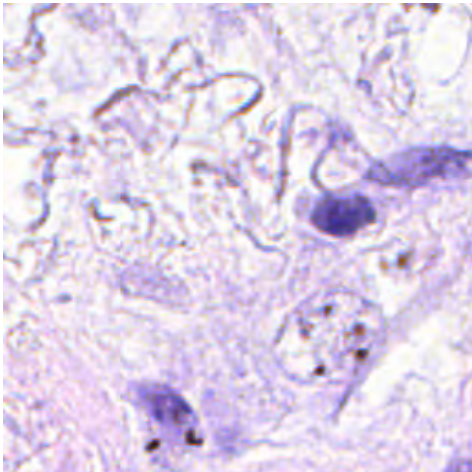


图1 HE $\times 200$ ，显示肿瘤细胞呈腺样结构排列，部分区域可见不规则腺腔形成，腔内充满癌细胞，核异型性明显，核仁清晰，染色质粗颗粒状分布。背景中可见少量炎症细胞浸润及纤维组织增生。

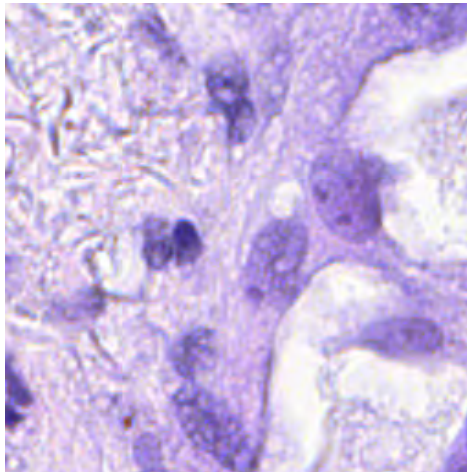


图2 HE $\times 200$ ，显示肿瘤细胞巢状排列，细胞核增大、深染，形态不规则，核仁明显，胞浆相对较少，呈淡粉色。无明显腺管结构，组织结构紊乱，提示侵袭性生长模式。

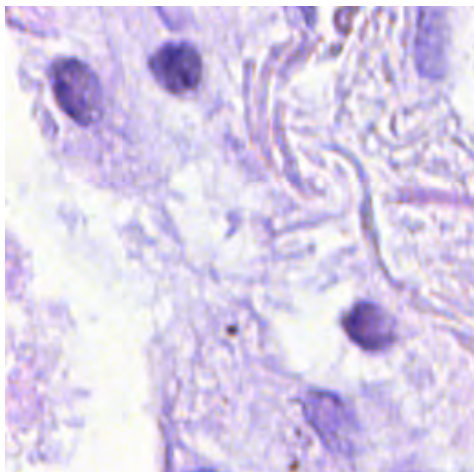


图3 HE ×200，显示肿瘤细胞密集排列成团块状，细胞核显著异型，大小不一，染色加深，部分细胞核出现明显的核分裂象。背景中有散在的炎细胞浸润，未见明显坏死区域。

四、病理诊断

本病例为Query Case (TCGA-05-4245-01Z-00-DX1.36ff5403-d4bb-4415-b2c5-7c750d655cde_8d636ea4ea473bae)，经综合分析其高注意力区域图像、预测类别及检索到的相似病例报告，最终诊断如下：

该标本来源于肺上叶，表现为浸润性恶性肿瘤，组织学形态以腺样结构为主，伴有不规则腺腔形成，肿瘤细胞核异型性显著，核仁明显，染色质粗颗粒状，部分区域可见核分裂象。肿瘤细胞呈巢状或片状排列，缺乏正常肺组织结构，背景有轻度炎症反应及纤维化改变。结合免疫组化结果，肿瘤细胞弥漫表达TTF-1，CK7/20部分阳性，CEA强阳性，Ki-67约30%，CK5阴性，符合肺腺癌的典型免疫表型特征。

尽管模型预测类别倾向于TCGA-LUSC（肺鳞癌），但通过高注意力patch图像分析与检索证据比对，发现其主要形态学特征更符合肺腺癌，尤其是存在明确的腺样结构和TTF-1强阳性表达，而鳞癌常见的角化、细胞间桥等特征未见。因此，排除肺鳞癌可能性，最终诊断为**原发性肺腺癌，低分化（Grade 3）**。

根据检索报告提供的分期信息，肿瘤最大径约3.2

cm，pT2，pN2（淋巴结转移），pV1（血管侵犯），pMx，临床分期为III A期。切缘状态未提及，建议结合手术记录进一步确认是否达到R0切除。

综上所述，本例为**原发性肺腺癌，低分化，pT2 pN2 pV1 pMx，III A期**。诊断依据包括：典型的腺样结构、核异型性、TTF-1强阳性、CK5阴性以及Ki-67中等水平表达。需注意的是，虽然模型预测倾向鳞癌，但形态学与免疫表型均支持腺癌诊断，故以实际组织学与分子证据为准。

五、备注

本报告仅对送检标本负责。建议结合临床影像学资料及分子检测（如EGFR、ALK、ROS1等基因突变检测）进一步明确治疗方案。若存在多灶性或混合性成分，建议行多区域取材以评估异质性。